UN CAZ PE SĂPTĂMÂNĂ™ · BONUS 1

100 întrebări clinice comentate

Date clinice scurte, o întrebare, patru variante de răspuns. 100 de cazuri în 10 blocuri; la finalul fiecărui bloc, cheia de răspuns și un scurt comentariu despre motivul pentru care răspunsul este corect.

Manualul Ortodontului

Cuprins

Cum să lucrezi cu acest material

Blocul 1 · Diagnostic de bază și clasificare · Întrebările 1–10

Blocul 2 · Cefalometrie · Întrebările 11–20

Blocul 3 · Planificare și timing · Întrebările 21–30

Blocul 4 · Managementul spațiului · Întrebările 31–40

Blocul 5 · Ancoraj și mini-implanturi · Întrebările 41–50

Blocul 6 · Clasa II · Întrebările 51–60

Blocul 7 · Clasa III · Întrebările 61–70

Blocul 8 · Probleme verticale și transversale · Întrebările 71–80

Blocul 9 · Mecanici complementare · Întrebările 81–90

Blocul 10 · Finisare, contenție, traumatism și anchiloză · Întrebările 91–100

Pasul următor

START

Cum să lucrezi cu acest material

Un bloc durează aproximativ 15 minute. Un bloc pe săptămână, în paralel cu programul de 52 de săptămâni.

1. **Rezolvă blocul cronometrat.** Notează răspunsurile lângă întrebare; nu te uita în cheia de răspuns.
2. **Compară cu cheia.** Citește comentariul la întrebările pe care le-ai greșit sau la care ai fost nesigur.
3. **Revino la sursă.** La începutul fiecărui bloc este menționat modulul corespunzător din Manual și numărul hărților vizuale.
4. **Notează scorul.** În rândul de la finalul blocului, notează numărul de răspunsuri corecte și data; după o lună, rezolvă din nou același bloc.

BLOC	TEMĂ	SĂPTĂMÂNA RECOMANDATĂ
1–2	Diagnostic de bază, cefalometrie	În timpul sau după săptămânile 1–11
3	Planificare și timing	Săptămânile 12–16
4–5	Managementul spațiului, ancoraj și mini-implanturi	Săptămânile 17–23
6–7	Clasa II, Clasa III	Săptămânile 24–31
8	Probleme verticale și transversale	Săptămânile 32–38
9	Mecanici complementare	Săptămânile 39–43
10	Finisare, contenție, traumatism și anchiloză	Săptămânile 44–52

Cazurile au scop educațional

Datele sunt ipotetice și au fost simplificate pentru a măsura un singur concept. La un pacient real, decizia se ia pe baza examinării complete și a documentației.

BLOCUL 1 · ÎNTREBĂRILE 1–10

Diagnostic de bază și clasificare

Lectură: Modulul 01 · Bazele și Cele 6 Chei ale Ocluziei; Modulul 02 · Diagnosticul Complet · Hărți vizuale: 1, 2, 9, 10, 17, 37, 38

Întrebarea 1

CAZ

13 ani. Relație molară de Clasa II completă pe ambele părți. Overjet 8 mm, incisivii superiori sunt proclinați.

Care este clasificarea Angle?

A) Clasa II diviziunea 1
B) Clasa I
C) Clasa II diviziunea 2
D) Clasa III

Întrebarea 2

CAZ

15 ani. Relație molară de Clasa II. Incisivii centrali superiori sunt retroclinați, cei laterali sunt proclinați, overbite adânc.

Care este cea mai probabilă clasificare?

A) Clasa II diviziunea 1
B) Clasa I cu ocluzie adâncă
C) Pseudo-Clasa III
D) Clasa II diviziunea 2

Întrebarea 3

CAZ

10 ani. Pe partea dreaptă molară clasa I, pe partea stângă clasa II de o jumătate de unitate. Linia mediană inferioară este deviată cu 2 mm spre stânga.

Care este prima etapă?

A) Inițierea imediată a elasticelor de clasa II pe partea stângă
B) Planificarea extracției premolarului superior stâng
C) Verificarea ocluziei în relație centrică, diferențierea derapajului funcțional de asimetria reală
D) Așteptarea timp de un an fără nicio intervenție

Întrebarea 4

CAZ

9 ani. Ocluzie inversă laterală pe partea dreaptă. În relație centrică liniile mediane coincid, în ocluzie centrică linia mediană inferioară deviază spre dreapta.

Care este diagnosticul cel mai probabil?

A) Asimetrie mandibulară reală

B) Derapaj funcțional cauzat de un maxilar îngust

C) Ocluzie inversă dentară limitată la un singur dinte

D) Anchiloză ATM

Întrebarea 5

CAZ

25 de ani. În poziție de repaus se observă prea mult din incisivii superiori. Lungimea buzei superioare și lungimea coroanelor sunt normale. La zâmbet este vizibilă gingia.

La ce cauză te gândești în primul rând?

A) Hipercreștere maxilară verticală sau extruzie dentoalveolară superioară

B) Buză superioară scurtă

C) Erupție pasivă

D) Retruzie mandibulară

Întrebarea 6

CAZ

11 ani. Caninul superior drept nu este palpabil vestibular, cel stâng este. Caninul temporar este pe arcadă.

Care este abordarea corectă?

A) Așteptarea timp de doi ani fără documentație

B) Descoperire chirurgicală imediată și tracțiune

C) Lăsarea caninului temporar fără monitorizare

D) Evaluarea situației prin radiografie panoramică, planificarea unei investigații suplimentare (3D) dacă este necesar

Întrebarea 7

CAZ

În arcada inferioară există o înghesuire de 7 mm. Curba Spee inferioară este de aproximativ 3 mm.

Cum interpretezi cel mai bine necesarul total de spațiu pe arcada inferioară?

A) Exact 7 mm

B) 4 mm, curba Spee câștigă spațiu

C) Mai mult de 7 mm; nivelarea curbei Spee necesită, de asemenea, spațiu

D) Analiza spațiului nu ia în considerare curba Spee

Întrebarea 8

CAZ

În analiza Bolton, raportul anterior este ridicat: incisivii inferiori sunt mari în comparație cu cei superiori.

Ce soluție poate fi luată în considerare?

A) Discrepanța Bolton nu are efect clinic

B) Stripping (IPR) în regiunea frontală inferioară sau mărirea restaurativă a incisivilor laterali superiori

C) Extracția premolarilor superiori este obligatorie

D) Este necesară expansiunea maxilară rapidă

Întrebarea 9

CAZ

14 ani. La deschiderea gurii deviază spre stânga, click în ATM-ul drept. Nu există durere.

Ce faci înainte de tratament?

A) Notezi constatarea în documentația inițială, informezi pacientul și familia, soliciți investigații suplimentare dacă este necesar

B) Deoarece nu există durere, nu notezi

C) Refuzi tratamentul în orice caz

D) Aplici imediat un aparat funcțional

Întrebarea 10

CAZ

8 ani. Înghesuire de aproximativ 2 mm la incisivii permanenți inferiori. Caninul temporar și molarii temporari sunt pe poziție.

Care este interpretarea corectă?

A) Este necesară extracția premolarilor în orice caz

B) Expansiunea maxilară rapidă este obligatorie

C) Tratamentul fix trebuie început imediat

D) Este frecventă în dentiția mixtă; monitorizăm prin analiza spațiului și luând în considerare spațiul Leeway

Modulul 1 · Răspunsuri și comentarii

ÎNTREBARE	RĂSPUNS	COMENTARIU
1	A	**Clasa II diviziunea 1.** Overjet-ul crescut și incisivii superiori proclinați indică diviziunea 1. Originea scheletală se evaluează separat, prin cefalometrie.
2	D	**Clasa II diviziunea 2.** Centralii retroclinați, lateralii proclinați și ocluzia adâncă sunt tiparul clasic al diviziunii 2.
3	C	**Verificarea ocluziei în relație centrică, diferențierea derapajului funcțional de asimetria reală.** Diferența de clasă unilaterală și deviația liniei mediane necesită mai întâi verificarea RC–OC; alegem mecanica doar după clarificarea cauzei.
4	B	**Derapaj funcțional cauzat de un maxilar îngust.** Dacă în relație centrică liniile mediane se aliniază, acesta este semnul principal al derapajului funcțional.
5	A	**Hipercreștere maxilară verticală sau extruzie dentoalveolară superioară.** Dacă lungimea buzei și a coroanei sunt normale, în spatele zâmbetului gingival stau cauze maxilare verticale și dentoalveolare.
6	D	**Evaluarea situației prin radiografie panoramică, planificarea unei investigații suplimentare (3D) dacă este necesar.** Nepalparea unilaterală avertizează asupra unui canin inclus; evaluăm mai întâi poziția și rădăcinile adiacente.
7	C	**Peste 7 mm; alinierea curbei Spee necesită, de asemenea, spațiu.** Nivelarea unei curbe Spee accentuate necesită spațiu suplimentar pe perimetrul arcului.
8	B	**IPR în regiunea frontală inferioară sau mărirea restaurativă a incisivilor laterali superiori.** Discrepanța de mărime dentară la finalizare influențează overjet-ul și punctele de contact; poate fi echilibrată prin IPR sau corecție restaurativă.
9	A	**Notezi constatarea în documentația inițială, informezi pacientul și familia, soliciți investigații suplimentare dacă este necesar.** Constatările la nivelul ATM trebuie documentate înainte de începerea tratamentului; informăm pacientul și, dacă este cazul, urmează investigații suplimentare.
10	D	**Frecvent în dentiția mixtă; monitorizăm prin analiză de spațiu și luând în calcul spațiul Leeway.** În dentiția mixtă timpurie, înghesuirile ușoare ale incisivilor inferiori sunt frecvente; decidem pe baza monitorizării și a analizei de spațiu.

Răspunsuri corecte: ___ / 10 Data: Data repetării:

MODULUL 2 · ÎNTREBĂRILE 11–20

Cefalometrie

Lectură: Modulul 02 · Diagnosticul Complet · Hărți vizuale: 3, 40, 41, 42 · Caiet de exerciții pentru analiză cefalometrică

Întrebarea 11

CAZ

SNA 82°, SNB 76°, ANB 6°.

Care este interpretarea cea mai precisă?

A) Clasa II scheletală cu prognatism maxilar predominant

B) Clasa I scheletală

C) Clasa III scheletală

D) Clasa II scheletală cu retruzie mandibulară predominantă

Întrebarea 12

CAZ

SNA 86°, SNB 80°, ANB 6°.

Care este interpretarea cea mai precisă?

A) Clasa II scheletală cu retruzie mandibulară predominantă

B) Clasa III scheletală

C) Clasa II scheletală cu prognatism maxilar predominant

D) Relație sagitală normală

Întrebarea 13

CAZ

ANB 2°, Wits +5 mm. Planul SN pare vizibil înclinat.

Cum interpretezi?

A) Deoarece ANB este normal, pacientul este cu siguranță Clasa I scheletală

B) ANB poate fi înșelător; evaluăm împreună cu valoarea Wits, profilul și alte măsurători

C) Valoarea Wits nu are semnificație clinică

D) Înclinarea SN nu influențează ANB

Întrebarea 14

CAZ

FMA 34°, SN-GoMe 40°.

Care este tiparul vertical?

A) Hiperdivergent

B) Hipodivergent

C) Normodivergent

D) Nu poate fi determinat cu aceste valori

Întrebarea 15

CAZ

FMA 18°. Overbite adânc.

Care afirmație este adevărată pentru acest tipar vertical?

A) Extruzia molară este strict contraindicată

B) Există un risc mare de ocluzie deschisă

C) Pentru controlul vertical, intruzia posterioară este prioritară

D) Extruzia posterioară este mai bine tolerată, dar există o tendință puternică spre ocluzie adâncă

Întrebarea 16

CAZ

IMPA 102°. Pentru camuflajul Clasei II se planifică elastice de Clasa II pe termen lung.

Care este cel mai important risc?

A) Retroînclinarea incisivilor inferiori

B) Intruzia molarilor superiori

C) Accentuarea suplimentară a proînclinării incisivilor inferiori; risc parodontal și de stabilitate

D) Creșterea spontană a overbite-ului

Întrebarea 17

CAZ

U1-SN 115°. Overjet 8 mm, ANB 3°.

Care este interpretarea cea mai precisă pentru overjet?

A) Overjet-ul este în întregime scheletal

B) O parte semnificativă a overjet-ului provine din proînclinarea incisivilor superiori

C) Incisivii superiori sunt retroînclinați

D) Înclinarea incisivilor nu are legătură cu overjet-ul

Întrebarea 18

CAZ

Pacient Clasa III. ANB −3°, IMPA 80°, U1-SN 112°.

Ce indică înclinarea incisivilor?

A) Compensare dentoalveolară naturală: incisivii superiori sunt proînclinați, cei inferiori sunt retroînclinați

B) Decompensarea este finalizată

C) Înclinarea ambilor incisivi este normală

D) Incisivii superiori sunt retroînclinați, cei inferiori sunt proînclinați

Întrebarea 19

CAZ

Pe trasaj desenezi planul mandibular.

Pentru unghiul SN-GoMe, prin ce puncte trece planul mandibular?

A) Porion și Orbitale

B) Sella și Nasion

C) ANS și PNS

D) Gonion și Menton

Întrebarea 20

CAZ

Pentru măsurătoarea FMA desenezi orizontala de la Frankfurt.

Ce puncte definesc planul de la Frankfurt?

A) Sella și Nasion

B) ANS și PNS

C) Porion și Orbitale

D) Gonion și Menton

Blocul 2 · Răspunsuri și comentarii

ÎNTREBARE	RĂSPUNS	COMENTARIU
11	**D**	**Clasa II scheletală cu retruzie mandibulară predominantă.** SNA este normal, SNB este scăzut: diferența este dată de mandibulă.
12	**C**	**Clasa II scheletală cu prognatism maxilar predominant.** SNB este normal, SNA este ridicat: diferența este dată de maxilar.
13	**B**	**ANB poate fi înșelător; se evaluează împreună cu valoarea Wits, profilul și alte măsurători.** ANB este influențat de înclinarea planului SN și de poziția Nasion; în caz de discrepanță, măsurătorile complementare sunt decisive.
14	**A**	**Hiperdivergent.** Ambele unghiuri sunt mult peste normele clasice (FMA aprox. 25°, SN-GoMe aprox. 32°).
15	**D**	**Extruzia posterioară este mai bine tolerată, dar există o tendință puternică spre ocluzie adâncă.** Tiparul hipodivergent tolerează extruzia posterioară; avem în vedere tendința spre ocluzie adâncă și recidivă.
16	**C**	**Proclinarea suplimentară a incisivilor inferiori; risc parodontal și de stabilitate.** Elasticele de Clasa II înclină incisivii inferiori spre vestibular; la incisivii deja proclinați, acesta este un factor limitator.
17	**B**	**O parte semnificativă a overjet-ului provine din proclinarea incisivilor superiori.** U1-SN este mult peste normal, ANB este la limita normalului: componenta dentară domină.
18	**A**	**Compensare dentoalveolară naturală: incisivii superiori sunt proclinați, cei inferiori retroclinați.** În Clasa III, incisivii se înclină pentru a masca discrepanța scheletală; în planul chirurgical, eliminăm această compensare.
19	**D**	**Gonion și Menton.** SN-GoMe este unghiul format de planul SN și planul Go-Me.
20	**C**	**Porion și Orbitale.** Planul orizontal de la Frankfurt trece prin Porion și Orbitale.

Răspunsuri corecte: ___ / 10 Data: Data repetării:

MODULUL 3 · ÎNTREBĂRILE 21–30

Planificare și temporizare

Lectură: Modulul 03 · Planificarea Clinică: de la Lista de Probleme la Mecanică · Hărți Vizuale: 19, 43–52 · Instrumentul 4 · Planificator Clinic în 4 Etape

Întrebarea 21

CAZ

13 ani. Clasa II diviziunea 1, ocluzie adâncă, înghesuire ușoară. Trebuie să redactezi lista de probleme.

Care este abordarea corectă?

A) Alegerea aparatului mai întâi și adaptarea listei de probleme în funcție de acesta

B) Notarea doar a acuzei principale a pacientului

C) Notarea problemelor separat pe plan sagital, vertical, transversal și în funcție de spațiu, apoi ierarhizarea lor

D) Enumerarea doar a valorilor cefalometrice

Întrebarea 22

CAZ

8 ani. Un singur incisiv superior în ocluzie inversă frontală. În relație centrică poate fi adus în poziție cap-la-cap. A început o recesiune gingivală pe incisivul inferior.

Care este cea mai potrivită decizie?

A) Așteptarea până la formarea completă a dentiției permanente

B) Evaluarea corecției timpurii

C) Planificarea unei intervenții ortognate

D) Utilizarea doar a unei gutiere nocturne

Întrebarea 23

CAZ

7 ani. Tendință ușoară de Clasa II, overjet 4 mm, fără traumatisme. Copilul nu este încă pregătit pentru tratament.

Care este cea mai potrivită abordare?

A) Monitorizarea și reevaluarea în timpul puseului de creștere

B) Începerea imediată a tratamentului fix

C) Planificarea extracției premolarilor superiori

D) Solicitarea unui consult chirurgical

Întrebarea 24

CAZ

Bărbat de 18 ani. Clasa III. ANB −6°, Wits −10 mm. Acuză pronunțată legată de profil.

Care este cel mai potrivit prim pas?

A) Începerea imediată a unui camuflaj cu elastice de Clasa III

B) Recomandarea unei măști faciale

C) Monitorizarea fără a oferi nicio altă opțiune

D) Confirmarea finalizării creșterii și recomandarea unui consult de chirurgie ortognată

Întrebarea 25

CAZ

Fată de 16 ani. Clasa II, ANB 5°, profil acceptabil. Nu există înghesuire în arcada inferioară, creșterea este în mare parte finalizată.

Ce opțiune poate fi luată în considerare?

A) Extracția obligatorie a patru premolari

B) Mască facială

C) Camuflaj prin extracția premolarilor superiori

D) Expansiune rapidă a maxilarului ca tratament unic

Întrebarea 26

CAZ

14 ani. Clasa II de o jumătate de unitate. Cooperare slabă cu elasticele și aparatele mobilizabile.

Ce depinde cel mai puțin de cooperare?

A) Aparat funcțional mobilizabil

B) Aparat funcțional fix sau mecanică susținută de mini-implanturi

C) Elastice de Clasa II

D) Placă mobilizabilă purtată noaptea

Întrebarea 27

CAZ

40 de ani. Există pierdere osoasă parodontală și inflamație activă.

Când poate fi început tratamentul ortodontic?

A) După finalizarea tratamentului parodontal și stabilizarea afecțiunii

B) Imediat; ortodonția reduce inflamația

C) Nu poate fi început niciodată

D) Doar după inserarea implanturilor

Întrebarea 28

CAZ

Incisivul lateral superior drept lipsește congenital. Forma și culoarea caninului sunt adecvate, nivelul gingival este diferit.

Cum decizi între închiderea spațiului sau deschiderea acestuia?

A) Deschidem întotdeauna spațiu pentru implant

B) Închidem întotdeauna spațiul

C) Decizia aparține exclusiv medicului protetician

D) Evaluând împreună morfologia caninului, culoarea, nivelul gingival, ocluzia și profilul, printr-o decizie de echipă

Întrebarea 29

CAZ

Planifici secvența mecanică.

Care este ordinea corectă?

A) Finisare → nivelare → faza de lucru → contenție

B) Faza de lucru → nivelare → contenție → finisare

C) Nivelare-aliniere → faza de lucru → finisare → contenție

D) Contenție → nivelare → finisare → faza de lucru

Întrebarea 30

CAZ

Realizezi un VTO pentru un caz adult.

Care este scopul principal al VTO?

A) Garantarea rezultatului final

B) Vizualizarea preliminară a efectului scontat al modificărilor planificate asupra profilului și ocluziei

C) Înlocuirea consimțământului informat utilizat în cabinetul tău

D) Eliminarea necesității cefalometriei

Blocul 3 · Răspunsuri și comentarii

ÎNTREBARE	RĂSPUNS	COMENTARIU
21	**C**	**Notează problemele separat pe plan sagital, vertical, transversal și în funcție de necesarul de spațiu, apoi ierarhizează-le.** Scriem lista de probleme pe dimensiuni; alegem mecanica la final.
22	**B**	**Cântărește corecția timpurie.** Derapajul funcțional și solicitarea parodontală sunt motive clasice pentru tratamentul timpuriu.
23	**A**	**Monitorizează și reevaluează în perioada de creștere.** Dacă nu există un motiv pentru tratament timpuriu, tratamentul într-o singură fază, efectuat la momentul potrivit, este de obicei mai eficient.
24	**D**	**Confirmă finalizarea creșterii și recomandă un consult de chirurgie ortognată.** Din cauza discrepanței scheletale mari și a nemulțumirilor legate de profil, opțiunea chirurgicală trebuie discutată.
25	**C**	**Camuflaj cu extracția premolarilor superiori.** În cazul unei arcade inferioare aliniate, se poate planifica un camuflaj doar cu extracții superioare, finalizând cu o Clasă II molară.
26	**B**	**Aparat funcțional fix sau mecanică susținută de mini-implanturi.** În cazul unei complianțe scăzute, devin prioritare opțiunile care nu depind de inserarea și îndepărtarea aparatului de către pacient.
27	**A**	**După finalizarea tratamentului parodontal și stabilizarea afecțiunii.** În prezența unei boli parodontale active, mișcarea dinților poate accelera pierderea osoasă.
28	**D**	**Evaluând împreună morfologia caninului, culoarea, nivelul gingival, ocluzia și profilul, printr-o decizie de echipă.** În cazul absenței unui incisiv lateral, nu există o singură cale corectă; evaluăm împreună aspectele estetice, ocluzale și parodontale.
29	**C**	**Nivelare-aliniere → faza de lucru → finisare → contenție.** Nu trecem la arcuri de lucru rigide și închiderea spațiilor înainte de finalizarea nivelării.
30	**B**	**Vizualizarea preliminară a efectului scontat al modificărilor planificate asupra profilului și ocluziei.** VTO este un instrument de planificare, nu o garanție a rezultatului.

Răspunsuri corecte: ___ / 10 Data: Data repetării:

MODULUL 4 · ÎNTREBĂRILE 31–40

Gestionarea spațiului

Lectură: Modulul 04 · Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi · Hărți Vizuale: 14, 16, 18, 53–61 · Instrumentul 2 · Hartă de Decizie: Extracție sau Conservare?

Întrebarea 31

CAZ

17 ani. Clasa I. Înghesuire inferioară de 9 mm, protruzie bimaxilară, buze proeminente.

Care este cea mai puternică opțiune?

A) Doar IPR
B) Plan cu extracții
C) Plan fără extracții cu înclinarea suplimentară a incisivilor
D) Doar monitorizare

Întrebarea 32

CAZ

26 ani. Înghesuire de 2,5 mm pe incisivii inferiori. Coroane triunghiulare, igienă orală bună.

Care opțiune este adecvată?

A) IPR
B) Extracția a patru premolari
C) Expansiune rapidă a maxilarului
D) Chirurgie ortognată

Întrebarea 33

CAZ

Risc crescut de carie, igienă orală deficitară și coroane mici. Înghesuire ușoară pe incisivii inferiori.

Care este decizia corectă privind IPR-ul?

A) Să efectuezi cât mai mult IPR
B) Să nu lustruiești după IPR
C) Să ignori factorii de risc
D) Să eviți IPR-ul sau să îl efectuezi foarte limitat

Întrebarea 34

CAZ

10 ani. Ocluzie inversă posterioară bilaterală. Maxilar îngust, boltă palatină adâncă.

Care este cea mai potrivită opțiune?

A) Doar elastice în cruce
B) Îngustarea arcadei inferioare
C) Expansiune rapidă a maxilarului (RME)
D) Așteptarea până la finalul creșterii

Întrebarea 35

CAZ

22 ani. Îngustare transversală scheletală. Os vestibular subțire, fenotip gingival subțire.

Care abordare este mai corectă?

A) Expansiune prin simpla înclinare vestibulară a dinților

B) Luarea în considerare a expansiunii asistate de mini-implanturi sau chirurgical, cu aviz parodontal

C) Aplicarea RME fără nicio evaluare prealabilă

D) Ignorarea îngustării transversale

Întrebarea 36

CAZ

9 ani. Al doilea molar temporar inferior stâng a fost pierdut prematur. Mai este timp până la erupția premolarului de sub el. Nu există încă pierdere de spațiu.

Care este cea mai potrivită opțiune?

A) Menținător de spațiu

B) Să nu faci nimic

C) Extracția imediată a premolarului

D) Elastice de Clasa III

Întrebarea 37

CAZ

11 ani. Molarii secunzi temporari inferiori sunt încă pe arcadă. Înghesuire de 3 mm la incisivii inferiori.

Care opțiune poate contribui la câștigarea de spațiu?

A) Extracția timpurie a molarilor temporari

B) Extracția incisivilor inferiori

C) Expansiune rapidă a maxilarului

D) Arc lingual pentru conservarea spațiului Leeway

Întrebarea 38

CAZ

Se efectuează distalizarea molarilor superiori.

Ce efect secundar este de așteptat la unitatea de ancoraj?

A) Retroînclinarea incisivilor

B) Distalizarea molarilor inferiori

C) Mișcarea mezială a premolarilor și incisivilor și proclinația incisivilor

D) Creșterea spontană a overbite-ului

Întrebarea 39

CAZ

16 ani. Clasa II diviziunea 1. Arcada inferioară este aliniată. Extragem doar primii premolari superiori.

Ce relație molară și canină vizăm la finalizare?

A) Clasa I molară, Clasa I canină

B) Clasa II molară, Clasa I canină

C) Clasa III molară, Clasa II canină

D) Clasa I molară, Clasa II canină

Întrebarea 40

CAZ

Este necesară o extracție pe arcada inferioară, dar nu dorim ca incisivii inferiori să fie retrași prea mult.

Care extracție poate fi preferată?

A) Premolarul secund inferior

B) Primul premolar inferior

C) Caninul inferior

D) Incisivul central inferior

Modulul 4 · Răspunsuri și comentarii

ÎNTREBARE	RĂSPUNS	COMENTARIU
31	**B**	**Plan de extracție.** Înghesuirile severe și protruzia sunt două argumente puternice în favoarea extracției.
32	**A**	**IPR.** Înghesuirile ușoare și coroanele în formă triunghiulară sunt condiții favorabile pentru IPR.
33	**D**	**Să eviți IPR-ul sau să îl efectuezi foarte limitat.** Riscul de carii și dimensiunea mică a coroanei sunt contraindicații pentru IPR.
34	**C**	**Expansiune rapidă a maxilarului (RME).** În perioada de creștere, îngustarea transversală scheletală poate fi tratată prin RME.
35	**B**	**Luarea în considerare a expansiunii asistate de mini-implanturi sau chirurgical, cu aviz parodontal.** La adult și în caz de fenotip subțire, expansiunea pur dentară crește riscul de pierdere gingivală și osoasă.
36	**A**	**Menținător de spațiu.** În cazul pierderii timpurii a molarului temporar, migrarea mezială a molarului permanent poate duce la pierderea spațiului.
37	**D**	**Arc lingual pentru conservarea spațiului Leeway.** Dacă păstrăm spațiul Leeway eliberat în timpul schimbării molarilor temporari, acesta poate ajuta la rezolvarea înghesuirii.
38	**C**	**Mișcarea mezială a premolarilor și incisivilor și proclinația incisivilor.** Forța egală și opusă forței de distalizare împinge înainte dinții de ancoraj.
39	**B**	**Clasa II molară, Clasa I canină.** În cazul extracțiilor doar la maxilar, molarii superiori rămân pe loc; aducem caninii în Clasa I.
40	**A**	**Premolarul secund inferior.** Extracția premolarului secund permite incisivilor inferiori să nu fie retrași excesiv, iar molarii să migreze mezial.

Răspunsuri corecte: ___ / 10 Data: Data repetării:

MODULUL 5 · ÎNTREBĂRILE 41–50

Ancoraj și mini-implanturi

Lectură: Modulul 04 · Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi · Hărți Vizuale: 11, 62–66

Întrebarea 41

CAZ

Protruzie bimaxilară. Extracția a patru premolari; scopul este retracția maximă a incisivilor.

Care este cea mai sigură opțiune de ancoraj?

A) Ancoraj direct cu mini-implant
B) Lanț elastic fără suport de ancoraj
C) Doar elastice de Clasa II
D) Doar gutieră de noapte

Întrebarea 42

CAZ

În timpul închiderii spațiilor, molarii superiori s-au deplasat mezial cu 3 mm, iar overjet-ul a scăzut mai puțin decât era prevăzut.

Care este problema?

A) Rezorbție radiculară
B) Derapaj funcțional
C) Discrepanță Bolton
D) Pierderea ancorajului

Întrebarea 43

CAZ

Iei în considerare utilizarea unui TPA.

Care este efectul principal al TPA?

A) Oferă prin sine însuși un ancoraj sagital absolut
B) Intrudează incisivii inferiori
C) Menține relația transversală dintre molari și controlează rotația molară
D) Expandează scheletal maxilarul superior

Întrebarea 44

CAZ

Pentru ancoraj suplimentar în arcada superioară se planifică un aparat Nance.

De unde își ia sprijinul aparatul Nance?

A) De pe incisivii inferiori
B) De pe butonul acrilic care se sprijină pe mucoasa palatului anterior
C) De pe mini-implanturi
D) Din zona extraorală

Întrebarea 45

CAZ

Planifici inserția unui mini-implant.

Ce verifici în principal înainte de inserție?

A) Distanța dintre rădăcini și volumul osos; dacă este posibil, gingia fixă

B) Doar zona preferată de pacient

C) Doar culoarea bracketului

D) Nu este necesară nicio evaluare radiologică

Întrebarea 46

CAZ

Mini-implantul se mișcă la câteva săptămâni după inserție.

Care sunt cele mai probabile cauze?

A) Întotdeauna vârsta pacientului este singura cauză

B) Culoarea necorespunzătoare a elasticelor

C) Schimbarea tipului de bracket

D) Contact radicular, os insuficient sau inflamație în jurul acestuia

Întrebarea 47

CAZ

Mini-implantul a fost legat de un premolar, forța fiind exercitată de pe premolar.

Ce tip de ancoraj este acesta?

A) Ancoraj direct

B) Ancoraj extraoral

C) Ancoraj indirect

D) Ancoraj reciproc

Întrebarea 48

CAZ

Adult. Din cauza pierderii dintelui antagonist, primul molar superior a suferit o extruzie. Este nevoie de spațiu vertical pentru restaurare.

Ce mecanică poate fi luată în considerare?

A) Extruzia suplimentară a molarului

B) Intruzia molarului susținută de mini-implant

C) Elastice de Clasa II

D) Expansiune rapidă a maxilarului

Întrebarea 49

CAZ

Adult. Tipar hiperdivergent, ocluzie deschisă frontală de 3 mm.

Care opțiune vizează problema verticală?

A) Luarea în considerare a intruziei posterioare cu mini-implanturi

B) Elastice de Clasa II purtate pe termen lung

C) Extruzie posterioară

D) Expansiune dentară necontrolată

Întrebarea 50

CAZ

În jurul mini-implantului apare hiperplazie gingivală și sensibilitate.

Care este primul pas?

A) Creșterea forței

B) Ignorarea constatării

C) Inserția unui al doilea șurub lângă mini-implant

D) Controlul igienei și al inflamației; dacă nu se ameliorează, îndepărtarea mini-implantului și luarea în considerare a unei alte zone

Blocul 5 · Răspunsuri și comentarii

ÎNTREBARE	RĂSPUNS	COMENTARIU
41	**A**	**Ancoraj direct cu mini-implant.** În cazurile care necesită ancoraj maxim, mini-implantul este opțiunea sigură care necesită cea mai puțină cooperare.
42	**D**	**Pierderea ancorajului.** Deplasarea mezială a molarilor și scăderea insuficientă a overjet-ului sunt semne tipice ale pierderii ancorajului.
43	**C**	**Menține relația transversală dintre molari și controlează rotația molară.** TPA contribuie limitat la ancorajul sagital; efectul său principal este controlul transversal și rotațional.
44	**B**	**De pe butonul acrilic care se sprijină pe mucoasa palatului anterior.** Aparatul Nance se sprijină pe mucoasa palatinală prin butonul acrilic; verifică igiena sub buton.
45	**A**	**Distanța dintre rădăcini și volumul osos; dacă este posibil, gingia aderentă.** Contactul radicular și osul insuficient se numără printre cele mai frecvente cauze ale eșecului.
46	**D**	**Contact radicular, os insuficient sau inflamație în jur.** În cazul unui mini-implant mobil, evaluează situația, osul și igiena; dacă este necesar, repoziționează-l în altă zonă.
47	**C**	**Ancoraj indirect.** În ancorajul indirect, mini-implantul fixează un dinte, iar forța este aplicată de pe acest dinte.
48	**B**	**Intruzia molară susținută de mini-implant.** Mini-implantul permite intruzia unui singur molar fără a influența dinții adiacenți.
49	**A**	**Evaluarea intruziei posterioare cu mini-implant.** Intruzia posterioară permite rotația antero-superioară a mandibulei, putând astfel reduce ocluzia deschisă.
50	**D**	**Controlul igienei și al inflamației; dacă nu se îmbunătățește, îndepărtarea mini-implantului și evaluarea unei alte zone.** Inflamația crește riscul de eșec; evaluează mai întâi igiena și încărcarea.

Răspunsuri corecte: ___ / 10 Data: Data repetării:

MODULUL 6 · ÎNTREBĂRILE 51–60

Clasa II

Lectură: Modulul 5 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III · Hărți vizuale: 12, 15, 67–72, 77 · Instrumentul 3 · Detector Vizual Clasa II vs. Clasa III

Întrebarea 51

CAZ

12 ani. Clasa II molară. ANB 2°. Incisivii superiori sunt proclinați.

Care este natura predominantă a acestei Clase II?

A) Scheletală, retruzie mandibulară
B) Scheletală, prognatism maxilar
C) Derapaj funcțional
D) Dentară

Întrebarea 52

CAZ

Băiat de 11 ani. SNB 74°, ANB 7°, FMA 24°. Aproape de vârful de creștere, cooperare bună.

Ce opțiune devine prioritară?

A) Chirurgie ortognată
B) Mască facială
C) Aparat funcțional
D) Doar extracția premolarilor inferiori

Întrebarea 53

CAZ

10 ani. Overjet 10 mm. Antecedente de traumatism și interpoziție labială.

Care este cea mai potrivită decizie?

A) Așteptarea erupției complete a dentiției permanente
B) Evaluarea reducerii timpurii a overjet-ului
C) Proclinarea doar a incisivilor inferiori
D) Doar monitorizare

Întrebarea 54

CAZ

Se utilizează tratamentul cu Twin Block.

Care este cel mai caracteristic efect secundar dentoalveolar?

A) Proclinarea incisivilor inferiori
B) Retroclinarea incisivilor inferiori
C) Proclinarea incisivilor superiori
D) Apariția unei ocluzii inverse laterale

Întrebarea 55

CAZ

Se utilizează elastice de Clasa II.

Care este un efect secundar tipic?

A) Retroclinarea incisivilor inferiori

B) Intruzia molarilor superiori

C) Creșterea overjet-ului

D) Extruzia molarilor inferiori și proclinarea incisivilor inferiori

Întrebarea 56

CAZ

FMA 35°. Clasa II, tendință ușoară la ocluzie deschisă. Se ia în considerare utilizarea prelungită a elasticelor de Clasa II.

Care este interpretarea corectă?

A) La un pacient hiperdivergent, aceasta este cea mai sigură opțiune

B) Nu are niciun efect asupra dimensiunii verticale

C) Este necesară prudență; extruzia molară poate roti mandibula posterior și poate înrăutăți profilul

D) Închide întotdeauna ocluzia deschisă

Întrebarea 57

CAZ

Clasa II diviziunea 2, overbite adânc.

Ce faci mai întâi în timpul tratamentului?

A) Începerea imediată a elasticelor de Clasa II

B) Corectarea înclinării incisivilor centrali superiori și deschiderea ocluziei adânci

C) Extracția incisivilor inferiori

D) Aplicarea inițială a unui aparat de contenție

Întrebarea 58

CAZ

La un pacient în creștere cu Clasa II, cooperarea este o preocupare.

Ce opțiune reduce dependența de cooperare?

A) Aparat funcțional fix

B) Aparat funcțional mobil

C) Elastice de Clasa II

D) Gutieră nocturnă

Întrebarea 59

CAZ

20 de ani. ANB 9°, overjet 11 mm, retruzie mandibulară marcată, nemulțumire legată de profil.

Care este abordarea cea mai potrivită?

A) Doar elastice de Clasa II

B) Aparat funcțional

C) Doar IPR

D) Consiliere chirurgicală ortognată

Întrebarea 60

CAZ

În camuflajul ortodontic de Clasa II, incisivii superiori sunt retrași.

La ce trebuie să fii cel mai atent?

A) Pentru ca incisivii să fie cât mai verticalizați

B) Pentru ca forța să fie cât mai mare

C) Pentru controlul torque-ului; evitarea retroclinării excesive a incisivilor

D) Pentru adâncirea overbite-ului

Modulul 6 · Răspunsuri și comentarii

ÎNTREBARE	RĂSPUNS	COMENTARIU
51	**D**	**Dentar.** Cu un ANB normal, relația de Clasa II este explicată de poziția dinților.
52	**C**	**Aparat funcțional.** Retruzia mandibulară, tiparul vertical normal și perioada de creștere favorabilă sunt condiții potrivite pentru aparatul funcțional.
53	**B**	**Evaluarea reducerii timpurii a overjet-ului.** Overjet-ul mărit și traumatismul anterior sunt argumente puternice pentru intervenția timpurie.
54	**A**	**Proclinarea incisivilor inferiori.** În cazul aparatelor funcționale, incisivii inferiori tind să se încline spre anterior; acest lucru trebuie monitorizat.
55	**D**	**Extruzia molarilor inferiori și proclinarea incisivilor inferiori.** Elasticele de Clasa II trag arcada inferioară spre anterior și pot extruza molarii inferiori.
56	**C**	**Este necesară prudență; extruzia molarilor poate roti mandibula spre posterior și poate agrava profilul.** Tiparul hiperdivergent este sensibil la mecanicile de extruzie.
57	**B**	**Corectarea înclinării incisivilor centrali superiori și deschiderea ocluziei adânci.** Fără corectarea incisivilor retroclinați și a ocluziei adânci, relația sagitală nu poate fi citită corect.
58	**A**	**Aparat funcțional fix.** Aparatele funcționale fixe nu depind de complianța pacientului la inserție și îndepărtare.
59	**D**	**Consiliere pentru chirurgie ortognată.** În cazul unei discrepanțe scheletale mari la un pacient cu creșterea finalizată, camuflajul își atinge limitele.
60	**C**	**Pentru controlul torque-ului; evitarea retroclinării excesive a incisivilor.** Pierderea torque-ului influențează nefavorabil atât estetica, cât și overbite-ul.

Răspunsuri corecte: ___ / 10 Data: Data repetării:

MODULUL 7 · ÎNTREBĂRILE 61–70

Clasa a III-a

Lectură: Modulul 5 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III · Hărți Vizuale: 13, 73–76

Întrebarea 61

CAZ

7 ani. Ocluzie inversă frontală. În relație centrică, incisivii sunt în poziție cap la cap. Profil drept în repaus.

Care este diagnosticul cel mai probabil?

A) Clasa a III-a scheletală

B) Clasa II diviziunea 2

C) Pseudo-Clasa a III-a

D) Ocluzie în foarfecă

Întrebarea 62

CAZ

8 ani. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°. Overjet negativ.

Care opțiune poate fi luată în considerare?

A) Chirurgie ortognată imediată

B) Protracție maxilară timpurie cu mască facială

C) Elastice de Clasa II

D) Extracția premolarilor inferiori

Întrebarea 63

CAZ

9 ani. Tatăl are Clasa a III-a. ANB −2°.

Ce trebuie să transmiți familiei?

A) Beneficiul potențial al tratamentului timpuriu, faptul că odată cu creșterea poate apărea recidiva și că ulterior ar putea fi necesar un tratament suplimentar

B) Că tratamentul timpuriu va rezolva problema sigur și definitiv

C) Că niciun tratament nu ajută

D) Că aceasta este doar o problemă estetică

Întrebarea 64

CAZ

Adult. ANB −2°, profil acceptabil, pacientul nu dorește chirurgie.

Cum deplasezi incisivii în cadrul camuflajului?

A) Înclinăm incisivii superiori spre posterior, iar pe cei inferiori spre anterior

B) Verticalizăm ambii incisivi

C) Nu deplasăm incisivii

D) Înclinăm incisivii superiori spre anterior, iar pe cei inferiori spre posterior

Întrebarea 65

CAZ

Pregătire ortodontică înainte de chirurgia ortognată de Clasa a III-a.

Care este scopul etapei de pregătire?

A) Accentuearea compensării

B) Eliminarea completă a overjet-ului negativ

C) Decompensarea: poziționarea incisivilor la înclinația corectă față de osul bazal

D) Corecția în așa măsură încât să nu mai fie nevoie de chirurgie

Întrebarea 66

CAZ

Se utilizează elastice de Clasa a III-a.

Care este efectul secundar tipic?

A) Proclinarea incisivilor inferiori

B) Proclinarea incisivilor superiori, retroclinarea incisivilor inferiori și extruzia molarilor superiori

C) Intruzia molarilor superiori

D) Creșterea overjet-ului

Întrebarea 67

CAZ

Se planifică tratamentul cu mască facială.

Care este perioada cea mai potrivită?

A) Dentiție mixtă timpurie, cât timp maxilarul este încă în creștere

B) După finalizarea creșterii

C) Doar la vârsta adultă

D) La ani buni după erupția molarilor secunzi permanenți

Întrebarea 68

CAZ

26 de ani. Un singur incisiv lateral superior în ocluzie inversă. Există un deficit de spațiu de aproximativ 2 mm pe arcadă.

În ce ordine corectezi?

A) Mai întâi împingerea incisivului vestibular cu forță

B) Chirurgie ortognată

C) Nu se intervine

D) Mai întâi crearea spațiului, apoi deplasarea incisivului vestibular

Întrebarea 69

CAZ

Ocluzie inversă frontală.

Care dintre următoarele semne indică o Clasă a III-a scheletală veritabilă?

A) Incisivii ajung în contact cap-la-cap în relație centrică

B) Doar un singur incisiv este în ocluzie inversă

C) Overjet-ul negativ se menține și în relație centrică, profil concav și antecedente familiale

D) Profil drept și derapaj funcțional

Întrebarea 70

CAZ

Băiat de 15 ani. Clasa a III-a scheletală, se ia în considerare chirurgia. Creșterea este încă activă.

Cum determini momentul oportun pentru intervenția chirurgicală?

A) Se efectuează imediat, în timpul creșterii

B) Așteptăm finalizarea creșterii; confirmăm prin radiografii seriate

C) Planificăm pentru aceeași dată, indiferent de vârstă

D) Momentul nu influențează rezultatul

Modulul 7 · Răspunsuri și comentarii

ÎNTREBARE	RĂSPUNS	COMENTARIU
61	**C**	**Pseudo-Clasa a III-a.** Contactul cap-la-cap obținut în relație centrică și profilul drept indică un derapaj funcțional anterior.
62	**B**	**Protracție maxilară timpurie cu mască facială.** În cazul retruziei maxilare, evaluăm protracția timpurie în perioada de creștere.
63	**A**	**Posibilul beneficiu al tratamentului timpuriu, faptul că creșterea poate duce la recidivă și că ulterior poate fi necesar un tratament suplimentar.** În Clasa a III-a familială, creșterea poate modifica rezultatul; așteptările trebuie setate corect de la început.
64	**D**	**Înclinăm incisivii superiori spre vestibular și pe cei inferiori spre lingual.** Camuflajul maschează discrepanța scheletală prin compensare dentoalveolară; respectăm limitele acestuia.
65	**C**	**Decompensare: aducerea incisivilor la o înclinare corectă față de osul bazal.** În timpul decompensării, overjet-ul negativ poate crește temporar; informăm pacientul în prealabil.
66	**B**	**Proclinarea incisivilor superiori, retroclinarea incisivilor inferiori și extruzia molarilor superiori.** Elasticele de Clasa a III-a tracționează arcada superioară anterior și pe cea inferioară posterior.
67	**A**	**Dentiție mixtă timpurie, cât timp maxilarul este încă în creștere.** Efectul scheletal al protracției este mai mare în stadiile timpurii.
68	**D**	**Mai întâi crearea spațiului, apoi deplasarea incisivului vestibular.** Fără spațiu, dintele nu poate fi aliniat pe arcadă; dacă este necesar, utilizăm înălțătoare de ocluzie temporare.
69	**C**	**Overjet-ul negativ se menține și în relație centrică, profil concav și antecedente familiale.** În Pseudo-Clasa a III-a, contactul cap-la-cap este posibil în relație centrică; în Clasa a III-a veritabilă, nu.
70	**B**	**Așteptăm finalizarea creșterii; confirmăm prin radiografii seriate.** După o intervenție chirurgicală efectuată în timpul creșterii, creșterea ulterioară a mandibulei poate compromite rezultatul.

Răspunsuri corecte: ___ / 10 Data: Data repetării:

MODULUL 8 · ÎNTREBĂRILE 71–80

Probleme Verticale și Transversale

Lectură: Modulul 6 · Probleme Verticale și Transversale · Hărți vizuale: 4–6, 79–92

Întrebarea 71

CAZ

9 ani. Obiceiul de supt al degetului. Ocluzie deschisă frontală de 3 mm. FMA 26°.

Care este tipul cel mai probabil și primul obiectiv?

A) Ocluzie deschisă scheletală; chirurgie ortognată

B) Ocluzie deschisă dentară cauzată de obicei vicios; mai întâi eliminarea obiceiului

C) Derapaj funcțional; RME

D) Ocluzie adâncă; intruzie

Întrebarea 72

CAZ

14 ani. FMA 36°, înălțime facială anterioară inferioară crescută, ocluzie deschisă frontală de 4 mm.

Ce indică acest tablou clinic?

A) Ocluzie deschisă scheletală; controlul vertical este prioritar

B) Ocluzie deschisă exclusiv dentară

C) Tipar hipodivergent

D) Tendință la ocluzie adâncă

Întrebarea 73

CAZ

11 ani. La deglutiție, limba se interpune între incisivi. În vorbire, sunetul „s" este distorsionat. Ocluzie deschisă de 2 mm.

Care este abordarea cea mai potrivită?

A) Închidere exclusiv cu elastice verticale

B) Așteptare fără nicio intervenție

C) Extracție de premolari

D) Plan multidisciplinar cu logoped, grilaj lingual dacă este necesar

Întrebarea 74

CAZ

Overbite 6 mm. În repaus se observă prea mult din incisivii superiori. La zâmbet se observă gingia.

Cum corectezi ocluzia adâncă?

A) Prin extruzia incisivilor superiori

B) Doar prin extruzie posterioară

C) În principal prin intruzia incisivilor superiori

D) Cu elastice de Clasa II

Întrebarea 75

CAZ

Overbite 6 mm. În repaus se observă puțin din incisivii superiori. FMA 20°.

Care opțiune este mai potrivită?

A) Intruzia incisivilor superiori

B) Extruzie posterioară și/sau intruzia incisivilor inferiori

C) Intruzie posterioară

D) Nicio mecanică verticală

Întrebarea 76

CAZ

24 de ani. Doar primul molar superior stâng este în ocluzie inversă. Lățimea arcadei superioare este adecvată.

Care este abordarea cea mai potrivită?

A) Corecție dentară locală

B) Expansiune rapidă a maxilarului

C) Expansiune asistată chirurgical

D) Mască facială

Întrebarea 77

CAZ

Se utilizează elastice în cruce pentru ocluzia inversă a unui singur molar.

Care este efectul secundar tipic?

A) Intruzia dinților

B) Proclinarea incisivilor

C) Corecția liniei mediane

D) Extruzia dinților

Întrebarea 78

CAZ

Dinții posteriori superiori se închid complet pe partea vestibulară a celor inferiori.

Cum se numește această ocluzie?

A) Ocluzie inversă posterioară

B) Ocluzie deschisă

C) Ocluzie în foarfecă

D) Alunecare funcțională

Întrebarea 79

CAZ

18 ani. Ocluzie inversă posterioară bilaterală. Fenotip gingival subțire, premolarii sunt deja înclinați vestibular.

Care opțiune este mai sigură?

A) Înclinarea vestibulară suplimentară a dinților

B) Evaluarea opțiunilor de expansiune scheletală cu aviz parodontal

C) Utilizarea prelungită a elasticelor în cruce

D) Nicio evaluare

Întrebarea 80

CAZ

La zâmbet se observă multă gingie. Coroanele clinice sunt scurte. Vizibilitatea incisivilor este normală.

La ce cauză trebuie să te gândești?

A) Erupție pasivă; evaluare parodontală

B) Hipercreșterea verticală maxilară ca diagnostic cert

C) Prognatism mandibular

D) Alunecare funcțională

Modulul 08 · Răspunsuri și comentarii

ÎNTREBARE	RĂSPUNS	COMENTARIU
71	**B**	**Ocluzie deschisă dentară cauzată de obicei; mai întâi eliminarea obiceiului.** La un tipar vertical normal, ocluzia deschisă asociată cu un obicei este de obicei dentară.
72	**A**	**Ocluzie deschisă scheletală; controlul vertical este prioritar.** FMA mare și înălțimea facială anterioară inferioară crescută indică o componentă scheletală.
73	**D**	**Plan multidisciplinar cu logoped, grilaj lingual dacă este necesar.** Ocluzia deschisă închisă fără tratarea funcției musculare tinde să recidiveze.
74	**C**	**În principal prin intruzia incisivilor superiori.** Din cauza vizibilității excesive a incisivilor, estetic este preferabilă intruzia incisivilor superiori.
75	**B**	**Extruzie posterioară și/sau intruzia incisivilor inferiori.** La o vizibilitate redusă a incisivilor, intruzia superiorilor afectează zâmbetul; tiparul hipodivergent tolerează extruzia posterioară.
76	**A**	**Corecție dentară locală.** Ocluzia inversă limitată la un singur dinte și lățimea adecvată a arcadei indică o problemă dentară.
77	**D**	**Extruzia dinților.** Componenta verticală a elasticelor în cruce extrudează dinții; trebuie monitorizat mai ales la pacienții hiperdivergenți.
78	**C**	**Ocluzie în foarfecă.** În ocluzia în foarfecă, contactul în sens vestibulo-lingual este complet pierdut.
79	**B**	**Evaluarea opțiunilor de expansiune scheletală cu aviz parodontal.** La dinții înclinați compensator, expansiunea dentară suplimentară crește riscul parodontal.
80	**A**	**Erupție pasivă; evaluare parodontală.** Coroanele clinice scurte și vizibilitatea normală a incisivilor indică o erupție pasivă.

Răspunsuri corecte: ___ / 10 Data: Data repetării:

MODULUL 09 · ÎNTREBĂRILE 81–90

Mecanici Complementare

Lectură: Modulul 07 · Mecanici Complementare · Hărți vizuale: 93–104

Întrebarea 81

CAZ

În timpul închiderii spațiilor la nivelul incisivilor, overbite-ul se adâncește și se pierde torque-ul. Arcul este subțire, iar forța este prea mare.

Ce trebuie să schimbi?

A) Să reduci forța, să treci la un arc rectangular din oțel care ocupă mai bine slotul și să controlezi torque-ul

B) Să crești forța și mai mult

C) Să treci la un arc rotund mai subțire

D) Să ignori adâncirea overbite-ului

Întrebarea 82

CAZ

Ai vrea să începi închiderea spațiilor prin mecanică de glisare.

Care este condiția pentru a începe?

A) Arcul flexibil din NiTi să rămână pe poziție

B) Colarea bracketurilor să nu fie încă finalizată

C) Aparatul de contenție să fie deja inserat

D) Nivelarea să fie finalizată și să existe un arc de lucru rectangular adecvat

Întrebarea 83

CAZ

Se ia în considerare mecanica cu bucle (loop).

Care este principalul avantaj?

A) Nu necesită deloc activare

B) Facilitează igiena

C) Fără fricțiune; forța și cuplul pot fi reglate prin geometria buclei

D) Depinde de cooperarea pacientului

Întrebarea 84

CAZ

A fost corectat un incisiv lateral puternic rotat.

Care este cauza principală a recidivei rotației?

A) Modificarea culorii bracketului

B) Remodelarea tardivă a fibrelor gingivale supraalveolare

C) Creșterea overjet-ului

D) Lipsa utilizării unui mini-implant

Întrebarea 85

CAZ

Canin superior inclus palatinal. Există spațiu, poziția a fost determinată.

Ce este important înainte de tracțiune?

A) O unitate de ancoraj rigidă și planificarea unei direcții a forței care să evite rădăcinile adiacente

B) Forța să fie cât mai mare posibil

C) Dinții de ancoraj să rămână pe un arc flexibil

D) Să nu se efectueze investigații imagistice suplimentare

Întrebarea 86

CAZ

În timpul tracțiunii caninului inclus, nu există nicio mișcare de luni de zile, iar dinții de ancoraj se intrudează.

La ce trebuie să te gândești?

A) Să dublezi forța

B) Să ignori intruzia dinților de ancoraj

C) Să treci la contenție

D) Suspiciune de anchiloză; investigație detaliată (Ghidul 4 · Traumatisme și Anchiloză)

Întrebarea 87

CAZ

Se verticalizează al doilea molar inferior.

Care este efectul secundar tipic?

A) Intruzia molarului

B) Retroclinarea incisivilor

C) Extruzia molarului și contact ocluzal prematur

D) Ocluzie inversă posterioară

Întrebarea 88

CAZ

În arcada superioară este necesară o expansiune dentoalveolară ușoară-moderată și derotația molarilor.

Ce aparat este adecvat?

A) Mască facială

B) Quad helix

C) Twin Block

D) Dispozitiv lingual fix

Întrebarea 89

CAZ

S-a efectuat distalizarea molarilor superiori cu Pendulum.

Ce efect secundar este de așteptat?

A) Deplasarea mezială a premolarilor și incisivilor; înclinarea distală a molarilor

B) Retroclinarea incisivilor

C) Înclinarea mezială a molarilor

D) Expansiunea arcadei inferioare

Întrebarea 90

CAZ

Fractură subgingivală la un incisiv central superior. Lungimea rădăcinii este suficientă. Este necesară o limită pentru restaurare.

Care poate fi contribuția ortodonției?

A) Intruzie ortodontică

B) Expansiune rapidă a maxilarului

C) Elastice de Clasa III

D) Extruzie ortodontică (erupție forțată)

Modulul 09 · Răspunsuri și comentarii

ÎNTREBARE	RĂSPUNS	COMENTARIU
81	**A**	**Să reduci forța, să treci la un arc rectangular din oțel care ocupă mai bine slotul și să controlezi torque-ul.** Arcul non-rigid și forța prea mare duc la o înclinare necontrolată a incisivilor.
82	**D**	**Nivelarea să fie finalizată și să existe un arc de lucru rectangular adecvat.** Închiderea spațiilor începută înainte de finalizarea nivelării duce la pierderea controlului asupra torque-ului și rotațiilor.
83	**C**	**Fără fricțiune; forța și cuplul pot fi reglate prin geometria buclei.** Buclele elimină fricțiunea, dar necesită îndoirea și activarea precisă.
84	**B**	**Remodelarea tardivă a fibrelor gingivale supraalveolare.** Fibrele supraalveolare rămân tensionate mult timp; luăm în considerare contenția și, dacă este necesar, fibrotomia.
85	**A**	**O unitate de ancoraj rigidă și planificarea unei direcții a forței care să evite rădăcinile adiacente.** În cazul unei direcții greșite a forței, crește riscul de resorbție a rădăcinilor adiacente.
86	**D**	**Suspiciune de anchiloză; investigație detaliată (Ghidul 4 · Traumă și Anchiloză).** Lipsa de mobilitate și efectul secundar asupra dinților de ancoraj indică anchiloză.
87	**C**	**Extruzia molarului și contact ocluzal precoce.** La redresare, rotația în jurul apexului radicular mezial ridică molarul.
88	**B**	**Quad helix.** Quad helix-ul se folosește pentru expansiune dentară ușoară-moderată și pentru derotația molarilor.
89	**A**	**Deplasarea mezială a premolarilor și a incisivilor; înclinarea distală a molarilor.** Unitatea de ancoraj se mișcă înainte; molarii se pot înclina distal în mod necontrolat.
90	**D**	**Extruzie ortodontică (erupție forțată).** Extruzia aduce linia de fractură deasupra gingiei și ușurează restaurarea.

Răspunsuri corecte: ___ / 10 | Data: | Data repetării:

BLOCUL 10 · ÎNTREBĂRILE 91–100

Finalizare, contenție, traumă și anchiloză

Lectură: Modulul 8 · Finalizare și Stabilitate · Hărți vizuale: 20, 105–114 · Ghidul 2 · Manualul de Contenție Ortodontică · Ghidul 4 · Traumă și Anchiloză

Întrebarea 91

CAZ

La finalizare, crestele marginale ale dinților vecini se află la niveluri diferite.

Ce faci?

A) Îndepărtezi imediat bracketii

B) Crești forța

C) Încerci să corectezi diferența prin contenție

D) Repoziționezi bracketii dinților afectați

Întrebarea 92

CAZ

În faza de finalizare verifici paralelismul rădăcinilor.

Care este abordarea corectă?

A) Te uiți doar la aspectul coroanelor

B) Nu folosești nicio radiografie

C) Evaluezi pe radiografia panoramică, ținând cont de distorsiune și interpretând-o împreună cu constatările clinice

D) Consideri imaginea panoramică o măsurătoare exactă

Întrebarea 93

CAZ

Finalizare. Linia mediană inferioară este deviată cu 2 mm spre dreapta. Nu există asimetrie scheletală și nici alunecare funcțională.

Care mecanică este potrivită?

A) Chirurgie ortognată

B) Corecție dentară cu mecanică asimetrică sau elastice asimetrice

C) Expansiune rapidă a maxilarului superior

D) Nicio corecție

Întrebarea 94

CAZ

Raportul incisivilor este bun, dar contactele posterioare din regiunea premolară sunt slabe.

Ce metodă se poate aplica?

A) Așezare ocluzală cu arc de finalizare elastic sau cu elastice verticale purtate pe termen scurt

B) Creșterea forței fără îndepărtarea bracketilor

C) Expansiune rapidă a maxilarului superior

D) Intruzie posterioară

Întrebarea 95

CAZ

La început exista diastemă superioară și rotații ale incisivilor inferiori.

Ce contenție recomanzi?

A) Nu este nevoie de contenție

B) Doar o placă mobilă timp de o lună

C) Doar sfaturi de igienă orală

D) Retainer lingual fix, completat la nevoie cu o gutieră de noapte

Întrebarea 96

CAZ

Pacient cu igienă slabă, care nu dorește retainer lingual fix, dar cooperează bine.

Ce opțiune poate fi luată în considerare?

A) Nicio contenție

B) Chirurgie ortognată

C) Retainer mobil (Hawley sau gutieră transparentă) și monitorizare strânsă

D) Retainer lingual fix, în pofida dorinței pacientului

Întrebarea 97

CAZ

La trei ani după încheierea tratamentului, înghesuirea incisivilor inferiori a revenit. Pacientul a încetat să poarte gutiera.

Care este cea mai probabilă explicație?

A) Tratamentul nu a funcționat deloc

B) Neglijarea contenției și modificările fiziologice care continuă odată cu vârsta

C) Exclusiv o discrepanță Bolton

D) Exclusiv o problemă de ATM

Întrebarea 98

CAZ

La control observi că unul dintre punctele de lipire ale retainerului lingual fix s-a desprins. Pacientul nu a observat.

Ce faci?

A) Reparație cât mai rapidă și verificarea dacă a apărut mișcare dentară în zona respectivă

B) Aștepți până la următorul control anual

C) Îndepărtezi complet retainerul, fără a oferi o altă soluție

D) Renunți la documentarea constatării

Întrebarea 99

CAZ

10 ani. În anamneză apare un traumatism la nivelul incisivului central superior. Se plănuiește tratament ortodontic.

Ce faci la început?

A) Nu documentezi antecedentul traumatic

B) Aplici forța maximă pe dintele traumatizat

C) Începi tratamentul fără evaluare

D) Evaluezi clinic și radiologic dintele traumatizat și documentezi; planifici cu forțe mici

Întrebarea 100

CAZ

Molar temporar în infraocluzie, dinții adiacenți s-au înclinat peste el. Nu există dinte permanent sub acesta.

Care este diagnosticul cel mai probabil și conduita terapeutică?

A) Erupție normală; doar monitorizare

B) Derapaj funcțional

C) Anchiloză; decizie de echipă luată la timp privind spațiul și nivelul osos

D) Elastice de Clasa II

Blocul 10 · Răspunsuri și comentarii

ÎNTREBARE	RĂSPUNS	COMENTARIU
91	**D**	**Repoziționezi bracketii afectați.** Diferența de nivel a crestelor marginale necesită corecția poziției bracketului.
92	**C**	**Evaluare pe radiografia panoramică, luând în calcul distorsiunea și corelarea cu datele clinice.** OPG-ul este un punct bun de orientare, dar poate conține distorsiuni.
93	**B**	**Corecție dentară prin mecanică asimetrică sau elastice asimetrice.** Devierea liniei mediane de origine dentară poate fi corectată prin mecanică dentară.
94	**A**	**Așezare ocluzală (settling) cu arc de finisare flexibil sau elastice verticale purtate pe termen scurt.** „Settling-ul" îmbunătățește contactele posterioare.
95	**D**	**Contentie linguală fixă, completată la nevoie cu gutieră nocturnă.** Diastema și rotațiile au un risc ridicat de recidivă.
96	**C**	**Aparat de contenție mobil (Hawley sau gutieră transparentă) și monitorizare atentă.** Alegem aparatul de contenție în funcție de igienă, complianță și preferințele pacientului.
97	**B**	**Neglijarea contenției și schimbările fiziologice care continuă odată cu vârsta.** Dinții au tendința de a se deplasa pe tot parcursul vieții; de aceea planificăm contenția pe termen lung.
98	**A**	**Reparație cât mai rapidă și verificarea dacă a avut loc vreo deplasare dentară în zona respectivă.** Dacă punctul de colaj desprins rămâne neobservat, pot apărea deplasări dentare nedorite.
99	**D**	**Evaluarea clinică și radiologică a dintelui traumatizat și documentarea acestuia; plan cu forțe ușoare.** Evaluăm dinții traumatizați înainte de tratament și îi documentăm; detaliile se află în Ghidul 4 (Traumatisme și Anchiloză).
100	**C**	**Anchiloză; decizie de echipă luată la timp privind spațiul și nivelul osos.** În cazul unui molar temporar anchilotic, întârzierea poate duce la înclinarea dinților adiacenți și diferențe de nivel osos.

Răspunsuri corecte: ___ / 10 Data: Data repetării:

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului și opinia de specialitate.

Pasul următor

Ai terminat cele 100 de întrebări? Alege cele două blocuri în care ai avut cele mai puține răspunsuri corecte și revino la săptămânile corespunzătoare din programul de practică de 52 de săptămâni.

Dacă la blocul de cefalometrie ai obținut sub 8 puncte, deschide **Caietul de exerciții pentru măsurători cefalometrice**. Pentru discutarea propriilor cazuri cu colegii, folosește materialul **Șabloane de prezentare a cazurilor pentru colegi**.

Pentru a decide mai rapid la scaun, ține la îndemână din Manualul Ortodontului **Instrumentul 2 · Hartă de Decizie: Extracție sau Conservare?** și **Instrumentul 3 · Detector Vizual Clasa II – Clasa III**.